

**教案名稱：**神經外科\_病史詢問(坐骨神經痛)

**說明：**45 歲男性，下背痛伴隨右腿麻痛兩週

**[Guidelines]**

**背景資料：**張建民，45 歲男性，兩週前搬重物後開始下背痛，最近幾天痛覺延伸到右側大腿和小腿，今天到神經外科門診就診，請你進行病史詢問。

**測驗主題：**

- 請進行詳細的病史詢問。
- 不需做理學檢查。

**測驗時間：**8 分鐘

**[Checklists]**

**測驗項目：**45 歲男性，下背痛與右腿麻痛 **測驗類型：**病史詢問

**通過分數：**14 分

**[Items]**

**評分項目**（每個項目皆需填入評分說明，關鍵詞以, 區隔）

**[1]**

**項目名稱：**向病患自我介紹，確認患者身分。(或問患者如何稱呼)

**完全做到：**自我介紹及確認患者身分兩項都有。

**部分做到：**僅有其中一項。

**沒有做到：**兩項皆缺。

**關鍵詞：**自我介紹, 確認身分, 如何稱呼

**[2]**

**項目名稱：**症狀開始的時間與發生經過 (Onset and duration)：什麼時候開始痛的？發作當時在做什麼？

**完全做到：**詢問疼痛開始的時間，並問及發作當時的情境(搬重物)。

**部分做到：**兩項只有一項做到。 **沒有做到：**兩項都沒做到。 **關鍵詞：**開始痛

的時間, 持續的時間, 發作情境

[3] 項目名稱：疼痛的位置與轉移 (Location & Radiation)：最痛的地方在哪裡？有沒有往下延伸(轉移)到臀部、大腿、小腿或腳趾？

完全做到：詢問背痛確切位置，且主動提及/詢問是否轉移至下肢特定部位。

部分做到：僅詢問背痛位置，未提及轉移。

沒有做到：沒有詢問疼痛的位置。

關鍵詞：痛的位置, 轉移痛, 臀部, 大腿, 小腿

[4]

項目名稱：疼痛的強度 (Severity)：pain score (VAS)：如果 1 分最不痛，十分最痛，病人為幾分痛？

完全做到：有詢問到疼痛的程度且量化 (VAS)。

部分做到：有詢問到疼痛的程度但未量化。 沒

有做到：沒有詢問到疼痛的強度。 關鍵詞：疼痛的強度, 幾分痛, 量化

[5]

項目名稱：疼痛的特徵為何 (Character)？(如像觸電般、抽痛、針刺感、麻木感)

完全做到：有問到疼痛的具體特徵或神經痛的表現。 部分做到：僅概略詢問。

沒有做到：完全沒有詢問特徵。 關鍵詞：觸電般, 抽痛, 針刺感, 麻木, 特徵

[6] 項目名稱：加強因素 (Aggravating factor) 與緩解因素 (Alleviating factor)：做什麼動作會比較痛 (如彎腰、咳嗽、打噴嚏)？做什麼會比較舒服 (如平躺)？

完全做到：有詢問加強因素(特別是腹壓增加的動作)與緩解因素。

部分做到：僅詢問其中一項。

沒有做到：兩項都沒有詢問。

關鍵詞：加強因素, 緩解因素, 彎腰, 咳嗽, 平躺

[7]

項目名稱：神經學相關危險徵候 (Red flags)：有沒有大小便失禁、尿不出來？肛門周圍有沒有麻木感（馬尾症候群）？

完全做到：有明確詢問大小便功能或會陰部麻木。

部分做到：僅隱晦詢問是否有其他嚴重症狀，未點出大小便。

沒有做到：沒有詢問危險徵候。

關鍵詞：大小便失禁, 尿不出來, 肛門麻木, 馬尾症候群

[8]

項目名稱：相關徵候 (Associated symptoms)：腳會不會覺得無力？走路會不會容易軟腳或拖地？

完全做到：有詢問下肢運動功能或無力狀況。

部分做到：只概略詢問腳有沒有不舒服。

沒有做到：沒有詢問無力症狀。

關鍵詞：腳無力, 軟腳, 拖地

[9]

項目名稱：過去病史與外傷史：以前有沒有受過嚴重的腰部外傷或車禍？以前有沒有類似的痛過？

完全做到：有詢問外傷史與過去類似發作史。

部分做到：僅詢問其中一項。

沒有做到：完全沒有詢問過去病史。

關鍵詞：外傷, 車禍, 類似經驗

[10]

項目名稱：職業與生活習慣：工作內容是否需要長期搬重物或久坐？是否有抽菸習慣？

完全做到：有詢問職業特性與抽菸史。

部分做到：僅詢問其中一項。

沒有做到：無詢問上述問題。 關鍵詞：職業, 搬重物, 久坐, 抽菸

[11]

項目名稱：目前的處理與用藥：這兩週有沒有去看過其他醫生？有沒有吃止痛藥或做復健？有沒有對藥物過敏？

完全做到：有詢問近期就醫用藥紀錄與過敏史。 部分做到：僅詢問其中一項。  
沒有做到：無詢問上述問題。

關鍵詞：看醫生, 止痛藥, 復健, 藥物過敏

[Patient]

人力和道具：45 歲男性標準病人一位(坐在椅子上，身體微偏向左側，避免右臀部受力，起身時動作緩慢痛苦)， 身體檢查(放置於桌面上)。

原則：

- 劇本未提供之訊息，在不協助/不阻礙考生得分的原則下，可自行決定回應方式，請參閱評分表，以了解演出之原則與底限。
- 考試時的回應心態請力持公平，不協助/不阻礙考生得分。

場景：神經外科門診

病人名稱：張建民

年齡：45 性別：男

扮演身分：患者本人

起始姿勢：坐在椅子上，身體微偏向左側，避免右臀部受力，起身時動作緩慢痛苦。

主訴及病史相關

主訴：兩週前搬貨閃到腰，這幾天右邊屁股到整條右腿又麻又痛。

主要臨床症狀：椎間盤突出併坐骨神經痛 (HIVD with Sciatica)。

現在病史：

- 兩週前上班搬一箱重物時，突然覺得下背部「喀」一聲，然後就開始劇烈疼痛。

- 一開始只有下背痛，但最近三天，痛的感覺一路往下跑到右邊臀部、右大腿後側，一直延伸到右小腿外側。
- 痛的感覺像一條線牽扯著，有時候像觸電一樣的抽痛，右小腿還會有麻麻的感覺。
- 痛的程度大約是 7 到 8 分痛（VAS）。
- 彎腰、咳嗽、用力解便時，大腿和背部的痛會像被電到一樣加劇。
- 躺在床上把腳稍微彎曲墊高會比較舒服，站久或坐久都會越來越痛。
- 目前大小便都很正常，沒有失禁，肛門附近也沒有麻木的感覺。
- 覺得右腳力氣稍微有點變差，但還能走路，沒有到完全軟腳拖地。

過去病史：無高血壓、糖尿病。大概五年前也有過下背痛，但休息幾天就好了，沒有像這次痛到腳。沒有出過嚴重車禍。

家族史：無特殊遺傳性疾病。

藥物史：這兩週有去藥局買過普拿疼跟貼布，但效果不好。沒有藥物過敏史。

其他病史：職業是物流司機兼送貨，常需要搬重物。一天抽一包菸，抽了快 20 年。